SDD 87 Sujet n°2

Spécialité : Dermatologie

Date : 05/05/24
Auteur : HARDY Quentin (DES dermatologie 2022)
Relecteur(s) :

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de la prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	350
Situation(s) de départ en lien avec la station	87 : Grosse jambe rouge aiguë
Matériel nécessaire à la station	2 chaises, une table.
Contexte de la station	Visite au domicile de Mme D., 87 ans

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale en stage chez le généraliste en milieu rural. Vous rendez visite chez elle, un vendredi après-midi, à Mme D., 87 ans.
Lors de la visite de la semaine précédente, vous aviez suspecté une TVP pour laquelle vous aviez réalisé un bilan. Sur la prise de sang faite hier, les D-dimères sont augmentés, et la CRP à 7 mg/L.

Vous concluez à une probable TVP droite, sans signe d'embolie pulmonaire associée.

Ses traitements sont AMLOR, NOCTAMIDE, DAFLON. Son dernier DFG, datant de 7 jours, s'établit à 56 ml/min.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes

- expliquer, en terme simple, le diagnostic de TVP et sa principale complication
- proposer une prise en charge diagnostique
- proposer une prise en charge thérapeutique, en accord avec la patiente

Vous ne devez pas :

- interroger le patient
- examiner la patiente
- réaliser d'ordonnances

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)	
Explique la TVP : caillot dans une des veines de jambe	1 pt
Explique le terme de caillot : sang coagulé / formant un bouchon *(ou tout synonyme acceptable)*	1 pt
Explique le risque aigu de la TVP : l'embolie pulmonaire	1 pt
Explique qu'une embolie pulmonaire correspond au déplacement du caillot de sang jusqu'aux vaisseaux du poumon	1 pt
Propose de prendre rdv : -en ambulatoire -pour une échographie doppler veineux de jambe droite	 1pt 1 pt
Prescrit : - un repos non strict au lit - un AOD - à débuter avant demain -à poursuivre jusqu'à l'échographie doppler	 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt
Enonce la nécessité de consulter en cas d'aggravation des symptomes	1 pt
Enonce les possibilités de consultation au moins 1 parmi : 15 - SAU - consultation chez le médecin généraliste	1 pt
Enonce les éléments à surveiller : ok si 2 - gêne à respirer - perte de connaissance (ou quasi malaise) - douleur dans la poitrine - crachat de sang	1 pt

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

1. **APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	**14 points**

Éléments de rétroaction :

La suspicion de TVP est très fréquente, avec bien souvent une absence de TVP finalement.

Ici, on suspecte une TVP non provoquée a priori, chez une patiente âgée, à fonction rénale considérée comme non impactant les traitements antithrombotiques.
Il n'y a pas d'argument pour une EP associée. Pas de contre-indication au traitement anti-thrombotique rapportée.

Dans un schéma "théorique" possible, il aurait fallu ici réaliser au domicile de la patiente une dose d'HBPM curative, puis probablement l'adresser au SAU (pour si nécessaire échographie veineuse de débrouillage par l'urgentiste, bilan biologique, +/- d-dimères, +/-angioscanner thoracique, etc.).
Le contexte particulier ici modifie ce schéma. C'était le but de l'ECOS : modifier ses propositions selon les demandes du patient, pour trouver un compromis acceptable par la patiente, et correct d'un point de vue médical.
Un AOD avec échographie doppler veineux dans les jours, en ville, est licite, seulement si les consignes de surveillance sont bien énoncées à la patiente.

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :
Vous êtes généraliste en milieu rural.

Vous rendez visite chez elle, un vendredi après-midi, à Mme D., 87 ans.

Vous l'aviez déjà rencontrée la veille pour un "érysipèle des deux jambes", avec prurit intense. Vous aviez diagnostiqué un eczéma variqueux que vous traitez par dermocorticoïdes.
Par contre, vous aviez remarqué que le mollet droit était notablement augmenté de volume par rapport au gauche, avec discrète douleur, et doute sur un cordon veineux induré. Sur la prise de sang faite hier, les D-dimères sont augmentés, et la CRP à 7 mg/L.

Vous concluez à une probable TVP droite, sans signe d'embolie pulmonaire associée.

Ses antécédents sont : HTA, lymphœdème des 2 jambes.

Ses traitements sont AMLOR, NOCTAMIDE, DAFLON. Son dernier DFG, datant de 7 jours, s'établit à 56 ml/min.

Plan de la station ECOS :

Patiente simulée en face du généraliste, autour de la table du salon.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour Docteur,
Alors qu'a dit la prise de sang faite hier ? J'ai une phlébite c'est ça !?

Identité du patient :

Mme D. 87 ans.

Mode de vie :

Au domicile avec son mari.

Pas de troubles cognitifs, mais caractère très “trempé”.
Autonome.

Comportement global :

Patiente respectueuse, mais très ferme

Antécédents personnels :

- HTA
- Lymphœdème des 2 jambes

Antécédents familiaux :

non pertinents

Médicaments :

AMLOR, NOCTAMIDE, DAFLON.

Symptômes positifs (à énoncer seulement si l’étudiant.e demande explicitement):

Si proposition d’aller au SAU le plus proche : “Oh vous savez Docteur, j’ai horreur des hôpitaux. Et puis c’est demain que nous fêtons nos noces de platine avec mon mari et toute la famille. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Donc hors de question d’aller à l’hôpital, ce n’est même pas la peine d’essayer Docteur”

Si proposition d’HBPM curative : “Surtout pas ! J’ai croisé un dentiste sadique quand j’étais môme… Depuis, j’ai une peur bleue de toute aiguille… Donc impossible de me faire la moindre piqûre, à moins d’une anesthésie générale… Déjà que pour les prises de sang c’est toute une histoire…”

Constantes :

Normales

Donnée complémentaire :

Néant

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

Si à 5 minutes, l'étudiant.e n'a pas évoqué les consignes de surveillance dans les jours à venir : "Et alors docteur, je vous remercie bien pour vos bons soins, mais s'il m'arrive quelque chose ce w-e, je fais quoi ??"

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patiente, assise, en face d'une table. De l'autre côté : l'étudiant, assis.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours